

RECURSO CÍVEL Nº 5070663-74.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: MAURO CABRAL TEIXEIRA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO MÉDICA EXPRESSA DO ENQUADRAMENTO DA DOENÇA DO AUTOR NO CONCEITO LEGAL DE ALGUMA PATOLOGIA ISENTIVA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CARDÍACA, MAS SEM INDICAÇÃO DO SEU GRAU A FIM DE AFERIR SEU ENQUADRAMENTO COMO GRAVE - ROL LEGAL TAXATIVO - NECESSIDADE DE SE ATESTAR E ENQUADRAR, DE MODO FUNDAMENTO E CIRCUNSTANCIADO, A PATOLOGIA DO AUTOR COMO GRAVE POR EXPERT NA MATÉRIA, ESPECIFICAMENTE PARA FINS DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA ATESTANDO O GRAU DA DOENÇA DO AUTOR A FIM DE ENQUADRÁ-LA COMO CARDIOPATIA GRAVE PARA FINS INSENTIVOS DO IMPOSTO DE RENDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, para determinar a produção de prova pericial sobre o autor e sobre a documentação médica apresentada com a apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste (ou não) a existência de cardiopatia grave para fins de isenção do imposto de renda, nos termos da legislação de regência. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da nº 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5070663-74.2024.4.02.5101

510014615129 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5070663-74.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: MAURO CABRAL TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste no reconhecimento do direito à isenção de IR sobre proventos de aposentadoria bem como restituição de valores já pagos àquele título, sob a alegação de estar acometido de cardiopatia grave pois é portador de *"ESTENOSE AÓRTICA CALCIFICADA (VALVA AÓRTICA BICÚSPEDÉ). CF NYHAI e CCS II, conforme laudo médico em anexo."*

Apresentou laudo de implante de marcapasso definitivo (evento 1, COMP5) dado o diagnóstico de Estenose Aórtica Calcificada (evento 1, COMP8). Apresentou exames e outras documentação do evento 1, COMP5 ao evento 1, COMP12.

Apesar de ser servidor público federal aposentado e o direito ser regularmente concedido em sede administrativa, aparentemente o autor não o requereu.

O juízo de origem julgou **procedente o pedido**, pois considerou presente a comprovação idônea acerca da existência de cardiopatia grave. Eis os fundamentos da procedência do pedido:

"(...)

No presente caso, alega o autor ser portador de cardiopatia grave, na modalidade estenose aórtica calcificada (valva aórtica bicúspede), com NYHAI e CCS II, levando tal enfermidade a impor o autor a submeter-se a procedimento cirúrgico para implante de Prótese Valvar Aórtico ("TAVI") e Marcapasso. Analisando toda documentação médica acostada aos autos (Evento 1, COMP5 ao COMP12), não há dúvidas acerca da veracidade das informações apresentadas na inicial, bem como da gravidade da enfermidade cardíaca.

(...)

Portanto, em consonância com os laudos e exames apresentados pela parte Autora nos presentes autos, verifico que o Autor é portador de cardiopatia grave, submetido a cirurgia cardíaca em 04/07/2024, realizando acompanhamento médico desde então, conforme documentação acostada no Evento 1, COMP5 ao COMP12, fazendo uso de marcapasso, tendo este sido implantado em 05/07/2024, como se constata pela sua carteira de portador de marcapasso (Evento 1, COMP12).

Assim, diante do conjunto probatório adunado aos autos, pode-se concluir que o Autor é portador de Cardiopatia grave desde julho de 2024.

*No caso concreto, portanto, **restou evidenciado o direito subjetivo à isenção de IR sobre os proventos de aposentadoria da parte Autora**, haja vista a subsunção do fato à norma instituidora de tal benefício fiscal.*

(...)"

Em sede recursal, a Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença, ante a ausência de enquadramento categórico da patologia do autor no art. 6.º inciso XIV da Lei 7.713/88.

É o relatório. Decido.

VOTO

A questão em tela passa pelo diagnóstico da doença e sua repercussão para fins de IR.

Preliminarmente, destaco o entendimento desta Relatoria quanto a matéria, notadamente acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo:

a) o requerimento administrativo é necessário e caracteriza o interesse de agir imprescindível, seja porque, sem ele, não haveria como a Fazenda reconhecer de ofício o direito à isenção; seja para que o Judiciário possa se ater apenas aos motivos pelos quais o eventual direito, que se alega indene de dúvidas, teria sido negado pelo ente encarregado de cuidar de assuntos como o presente, relativos à tributação. Para tanto se invoca o Tema Repetitivo 895 no qual o STF assegurou que a Administração necessariamente deve se manifestar previamente em pedidos de seguro de DPVAT que envolvem, tal como o presente, comprovação de condições de saúde necessárias para obtenção do benefício. Portanto, sem requerimento administrativo, o caso seria de extinção sem resolução do mérito;

b) havendo requerimento administrativo, superada a preliminar de ausência de interesse, mas sem perícia judicial, seria hipótese de anulação para sua realização; e

c) realizada perícia judicial, seria caso de julgamento do mérito, superando, excepcionalmente a preliminar do requerimento administrativo, em homenagem à celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos judiciais, considerando a realização da prova, às expensas do erário público.

Tudo isso está superado, ao menos até nova composição do colegiado, em deferência ao entendimento prevalente agora na 7ª Turma, o qual compreende como desnecessário o prévio requerimento administrativo para fins de interesse processual em casos como o presente.

No que tange à isenção de imposto por doença grave, limita-se a mesma à incidência do disposto no art. 6.º da Lei n.º 7.713/88, o qual preceitua nos seguintes termos:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, **alienação mental, esclerose múltipla**, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004). "GRIFOS NOSSOS

Consoante o disposto no art. 30 da Lei n.º 9.250/95, a comprovação da enfermidade que acarreta na isenção do imposto de renda deverá ser feita mediante **laudo pericial emitido por serviço médico oficial**, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Confira-se, a propósito:

"Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

§ 2º Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose)."

Note-se, portanto, que não se fala em incapacidade advinda da doença mas tão somente em constatação de sua presença.

O artigo 39 do Decreto 3.000/99 que regulamenta a matéria ratifica tal posicionamento, em especial quanto à prova necessária:

"Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto(II..)

§ 4º Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1º de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei nº 9.250, de 1995, art. 30 e § 1º).

§ 5º As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir:

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

§ 6º As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.(...)."

Todavia, a Corte Cidadã pacificou sua jurisprudência no sentido de que **"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."** (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Não consta dos autos laudo médico atestando a existência de cardiopatia grave ou parecer técnico do perito do juízo neste sentido. Tampouco os documentos médicos fazem menção específica à doença. O juízo entendeu que a mesma estaria presente com base nas conclusões do ecocardiograma bidimensional com color doppler, no qual consta existência de *"Estenose valvar aórtica grave"*, com indicação cirúrgica, constando no relatório médico o agravamento da enfermidade, já que o autor vinha apresentando angina e cansaço progressivo aos esforços, CF NYHA II e CCS II, associado, ainda, as demais comorbidades, como doença pulmonar obstrutiva crônica, e doença coronariana obstrutiva incipiente, evidenciando no ECG bloqueio do ramo direito em grau III.

É inegável que a parte autora possui problema cardíaco, mas nem todos eles podem ser tipificados como CARDIOPATIA GRAVE, que é a **doença** que assegura a isenção. A conclusão exposta na II Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (<https://diretrizes.cardiol.online/>): **"É correta a afirmativa de Besser 46 de que 'É preciso não confundir gravidade de uma cardiopatia com Cardiopatia Grave, uma entidade médico-pericial'.** Essencialmente, a classificação de uma Cardiopatia Grave não é baseada em dados que caracterizam uma entidade clínica, e sim, **nos aspectos de gravidade das cardiopatias, colocados em perspectiva com a capacidade de exercer as funções laborativas e suas relações como prognóstico de longo prazo e a sobrevivência do indivíduo.** Verifica-se uma dificuldade ainda maior na extensão do benefício aos inativos (aposentados), já que estes indivíduos não mais exercem a atividade laborativa (esforço físico), um dos fatores considerados importantes no julgamento pericial de incapacitação. Embora os **procedimentos intervencionistas e cirúrgicos sejam considerados na medicina pericial apenas parte da estratégia terapêutica aplicada aos doentes e, obviamente, não sejam considerados**

uma *doença* propriamente dita, sabemos que a cada intervenção corresponde uma *enfermidade cardiovascular importante subjacente, que deverá ser avaliada em relação à ação deletéria e às deficiências funcionais* que se possam imputar sobre a capacitação laboral do doente, como em todas as cardiopatias. Sabemos, também, que, num grande número de pacientes, a cirurgia ou o procedimento intervencionista alteram efetivamente a história natural da *doença* para melhor, modificando radicalmente a evolução de muitas doenças e, conseqüentemente, a categoria da gravidade da cardiopatia, pelo menos no momento da avaliação. Este é o conceito dinâmico de “reversibilidade” da evolução das cardiopatias, que deixam de configurar uma condição de Cardiopatia *Grave* observada anteriormente. De qualquer forma, nunca devemos achar, de antemão, que pacientes submetidos a quaisquer das intervenções mencionadas têm a condição médico-pericial de Cardiopatia *Grave*, como erroneamente interpretado por muitos. Considera-se um servidor (ativo ou inativo) como portador de Cardiopatia *Grave*, quando existir uma *doença* cardíaca que acarrete o total e definitivo impedimento das condições laborativas, existindo, implicitamente, uma expectativa de vida reduzida ou diminuída, baseando-se o avaliador na documentação e no diagnóstico da cardiopatia.”

Portanto, em que pese o quadro traçado pela documentação médica, não se sente este colegiado autorizado a concluir que o mesmo poderia ser categorizado como cardiopatia, em especial considerando que a parte autora sequer se sujeitou a perícia oficial pois se recusou a realizar o pedido administrativo previo.

Sem o laudo médico pericial particular ou oficial atestando a cardiopatia grave, não é possível este colegiado aferir sua presença por mera presunção extraída das informações médicas prestadas, dado não ser o juiz *expert* na matéria técnico-pericial em análise. Ainda que se considere o quadro de saúde da autora *grave*, tanto que precisou passar por cirurgia, é imprescindível a confirmação técnica e expressa da patologia isentiva até porque o rol de doenças contido no dispositivo legal é **taxativo (*numerus clausus*)** a teor da interpretação que deve ser dada aos institutos conforme o CTN.

Portanto, a concessão de isenção se restringe às situações nele enumeradas, sendo que no caso presente seria exceção pois dar-se-ia por equiparação, na medida em que nenhum dos documentos mencionam a doença isentiva expressamente.

Entende-se, assim, que a sentença deve ser anulada, para que haja certificação médica do perito do juízo (profissional imparcial) quanto a efetiva presença de cardiopatia, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA**, para determinar a produção de prova pericial sobre o autor e sobre a documentação médica apresentada com a apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado que atesta (ou não) a existência de cardiopatia grave para fins de isenção do imposto de renda, nos termos da legislação de regência. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da nº 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.